

12 胸部身体所見（視診，触診，打診，聴診）

physical examination of the chest (inspection, palpation, percussion, auscultation)

到達目標

- 視診で全身状態を把握できる
- 触診で喀痰の分泌状況がわかる
- 打診で病態の鑑別ができる
- 聴診で解剖学的事項を把握した病態の理解ができる

呼吸器疾患の診察においては、五感を十分に活用することが重要である。患者の見た目の印象で、呼吸困難があるか、また体の一部に痛みがあるかなども把握可能である。ここでは視診・触診・打診・聴診に分けてポイントを解説する。

視 診

眼球の陥凹、舌の乾燥は、脱水を示唆する。側頭筋の萎縮は低栄養を反映する。また、呼吸困難で来院した患者で、前傾姿勢をとる場合には閉塞性肺疾患を疑い、後傾姿勢をとる場合にはうっ血性心不全を考える。呼吸器疾患の患者では頸部に常に着目し、図1に示すように胸鎖乳突筋の肥大があれば慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease: COPD) などの可能性を考え、中斜角筋優位の肥大がある場合は間質性肺疾患などの拘束性疾患を考える。胸郭の前後径や肋間腔の開大は、閉塞性疾患のみならず高齢者の女性の圧迫骨折などでみられることがあるので区別が必要である。

Hoover's sign は吸気時に両側の肋骨弓の角度が鋭角になる所見であり、両方の肋骨弓に手を添えて評価し、患者の姿勢を半座位程度にすると適切に評価でき、高度の気流制限でみられる。奇異性運動は胸部と腹部の協調運動が消失する現象で、吸気時に胸部が陥凹して腹部が拡大する。呼吸筋疲労がある状態で認める。

触 診

慢性の呼吸器疾患の患者の急性期には呼吸補助筋を使用することが多く、直接補助筋に触れて確認する。胸部では触覚振盪が有用である。実際には片手の尺骨側を患者の背部にあて、患者に「ひとつ、ひとつ」とできるだけ低い声でゆっくりと発声してもらって手に響く感覚を調べる。特に左右差に気をつける。亢進している場合は限局性の肺炎を疑う。減弱や消失している場合は胸壁への音の伝導が妨げられている状態を示す。具体的には喀痰や胸水の貯留、無気肺、気胸、広範囲の胸膜肥厚などを考える。

縦隔気腫や皮下気腫の患者では、前胸部に握雪感を



図1 胸鎖乳突筋の肥大

[喜舎場朝雄：呼と循54：1341-1344, 2006より引用]

触診で確認することができる。rattling は前胸部にしっかり手掌を添えて、吸気時に分泌物による波動を触れる所見を指す。これは中枢気道での喀痰の貯留や肺活量低下を示唆する。

打 診

気胸が疑われる場合に、両側の鎖骨を直接たたくと、患側では音が鼓音になる。

打診は聴診と同様に前胸部、背部とも上から下に向けて、常に左右差を比較しながら、一方の手を患者の胸壁にぴったりと添えて中指の遠位指節関節を反対の手の中指でスナップを利かせてたたくとよい。大葉性肺炎、無気肺、胸水のある部位では打診で濁音となる。COPD は過膨張のために両側で過共鳴音となる。鼓音は巨大肺嚢胞や胃泡を示唆する。

聴 診

正常呼吸音は、前胸部や両側肺底部で左右を比較すると、吸気がしっかり聴取され呼気はほとんど聴取されない。ただし、気管前面では呼気の音が吸気とほぼ同等かむしろ強く聴取される。

呼吸う音は大きく連続性雑音と断続性雑音に分類される。主なう音を表1に示す。

wheezes は高調性と低調性とに分ける。喘息では一般に呼気時中心に高調性で polyphonic と呼ばれる多くの高さの連続性雑音が聴取される。喘息の場合には wheezes の強度は場所によって異なることが多い。また、その強度は必ずしも喘息発作の重症度とは相関せず wheezes が聴取されないときにはむしろ最重症の可能性もある。一方、低調の rhonchi が局所的にもつばら吸気時に聴取される場合には多くは分泌物を伴う